

VIH: diagnóstico, etapificación y evaluación inicial

Historia natural y etapas CDC · El algoritmo diagnóstico y la infección aguda · La primera consulta: qué pedir, qué decir y cómo decirlo

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A (diagnóstico y etapificación) y B (generalidades, historia natural, lenguaje y confidencialidad, evaluación inicial) — Sección VI

Glosario de siglas: VIH: virus de la inmunodeficiencia humana · SIDA: síndrome de inmunodeficiencia adquirida · TARV: terapia antirretroviral · CD4: linfocitos T CD4 · CV: carga viral · I=I: indetectable = intransmisible · ITS: infección de transmisión sexual · PPD/IGRA: pruebas de infección tuberculosa · AgCr: antígeno criptocócico · SIRS: síndrome inflamatorio de reconstitución inmune · HSH: hombres que tienen sexo con hombres · MINSAL: Ministerio de Salud de Chile · ISP: Instituto de Salud Pública de Chile · GES: garantías explícitas en salud.

Alcance y fuentes. Basado en las guías del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (DHHS) para adultos y adolescentes con VIH, las guías EACS, las recomendaciones de la OMS, la clasificación CDC 1993 y su revisión de 2014, y la normativa chilena (**Ley 19.779**, Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS del MINSAL, y garantías GES).

Verificar las normas nacionales vigentes. Complementa el documento *VIH* de la carpeta de referencia.

Índice

1. Nota sobre el lenguaje y la confidencialidad
2. Generalidades: el virus y su historia
3. Historia natural de la infección
4. Infección aguda: el síndrome retroviral agudo
5. Diagnóstico: los marcadores y su cronología
6. El algoritmo diagnóstico
7. El diagnóstico de VIH en Chile
8. Etapificación: la clasificación CDC
9. Condiciones definitorias de SIDA
10. La primera consulta: evaluación clínica
11. La primera consulta: exámenes
12. Vacunación
13. Cuándo iniciar la terapia antirretroviral
14. Vinculación a la atención y retención
15. Errores frecuentes
16. Perlas de alto rendimiento
17. Bibliografía esencial

1. Nota sobre el lenguaje y la confidencialidad

El lenguaje es parte del tratamiento. El estigma asociado al VIH deteriora la vinculación a la atención, la adherencia y los desenlaces clínicos, y una parte de ese estigma se reproduce en el lenguaje sanitario.

Lo que se dice y lo que no se dice:

| En lugar de... | Decir... | |---| | "Paciente VIH", "un VIH", "seropositivo" | **"Persona que vive con VIH"** o "persona con VIH" | | "Sídoso", "enfermo de SIDA" | "Persona con VIH en etapa avanzada" o "con enfermedad avanzada por VIH" | | "Contagiar", "infectar a otro" | **"Transmitir"** | | "Grupos de riesgo" | **"Prácticas de riesgo"** o "poblaciones clave" | | "Se lo buscó", juicios sobre la conducta | Descripción neutra de la exposición | | "Paciente promiscuo" | Número de parejas, si es clínicamente relevante | | "Test de SIDA" | **"Examen de VIH"** |

SIDA no es sinónimo de VIH: el SIDA es una **etapa** de la infección, hoy evitable con tratamiento oportuno. La mayoría de las personas con VIH en tratamiento **nunca desarrollará SIDA**.

Confidencialidad — en Chile, la Ley 19.779 establece que:

- El examen de VIH es **VOLUNTARIO** y requiere **consentimiento informado**.
- Debe ofrecerse **consejería pre y post test**.
- El **resultado es confidencial** y su revelación indebida está sancionada.
- Está **prohibida la discriminación** por el diagnóstico, incluidos el ámbito laboral y el educacional.
- **No se puede exigir el examen** como requisito para ingresar a un empleo, permanecer en él o acceder a servicios.

En la práctica clínica esto se traduce en: pedir el examen conversando con la persona y no como un examen más de la batería; entregar el resultado en persona y en privado; no consignar el diagnóstico en documentos accesibles a terceros sin necesidad clínica; y **no comunicarlo a familiares o parejas sin autorización**, trabajando en cambio con la persona la revelación a sus contactos.

2. Generalidades: el virus y su historia

- **VIH-1** (pandémico, con grupos M, N, O y P) y **VIH-2** (endémico de África occidental, de progresión más lenta y **con resistencia intrínseca a los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa** — un dato de relevancia terapéutica).
- **Retrovirus** con **ARN de cadena simple** y **transcriptasa reversa**, que **integra su genoma en el ADN del huésped** formando el **provirus** — la razón por la que la infección es **incurable con los tratamientos actuales** y requiere terapia de por vida.
- **Diana celular:** linfocitos **T CD4**, macrófagos y células dendríticas, a través del **receptor CD4** y de los **coreceptores CCR5 y CXCR4**.
- **Reservorio latente** en linfocitos T CD4 de memoria en reposo: se establece en los primeros días de la infección y es el obstáculo para la curación.
- **Hitos históricos:** primeros casos descritos en 1981 (neumonía por *Pneumocystis* y sarcoma de Kaposi en HSH previamente sanos); identificación del virus en 1983; primer antirretroviral (zidovudina) en 1987; **terapia antirretroviral combinada en 1996**, que transformó la enfermedad de mortal en crónica; y las etapas posteriores de simplificación (coformulaciones de un comprimido diario), de tratamiento como prevención (**I=I**) y de profilaxis preexposición.
- **Transmisión:** **sexual** (la principal), **sanguínea** (material compartido, transfusiones, exposición ocupacional) y **vertical** (embarazo, parto, lactancia). **No se transmite** por contacto casual, saliva, utensilios, insectos ni convivencia.

3. Historia natural de la infección

```
EXPOSICIÓN
| 2-4 semanas
INFECCIÓN AGUDA (síndrome retroviral agudo)
· Carga viral MUY alta (contagiosidad máxima)
· Caída transitoria de CD4
· Síntomas en 50-90 %, con frecuencia atribuidos a otra virosis
| semanas
SEROCONVERSIÓN -> establecimiento del *set point* viral
|
FASE CRÓNICA ASINTOMÁTICA (mediana ~8-10 años sin tratamiento)
· Descenso progresivo de CD4 (~50-100 células/μL por año)
· Replicación viral continua en tejido linfoide
· Puede haber linfadenopatía generalizada persistente
|
FASE SINTOMÁTICA (CD4 200-500): candidiasis oral, leucoplasia vellosa,
herpes zóster, tuberculosis pulmonar, trombocitopenia
|
SIDA (CD4 < 200 o condición definitoria)
· Infecciones oportunistas y neoplasias
· Sin tratamiento, supervivencia mediana ~1-2 años
```

Progresores atípicos:

- **Progresores rápidos** (~10 %): SIDA en menos de 5 años.
- **No progresores a largo plazo:** mantienen CD4 estables por más de una década sin tratamiento.
- **Controladores de élite** (< 1 %): mantienen **carga viral indetectable sin tratamiento**. Aun así se benefician del tratamiento, por la inflamación crónica persistente.

El **set point viral** —el nivel al que se estabiliza la carga viral tras la infección aguda— es el principal predictor de la velocidad de progresión en ausencia de tratamiento.

4. Infección aguda: el síndrome retroviral agudo

Es la oportunidad diagnóstica más valiosa y la más frecuentemente perdida.

- **Ocorre en el 50-90 % de las infecciones**, entre **2 y 4 semanas** tras la exposición.
- **Cuadro mononucleósico**: fiebre, **faringitis no exudativa**, adenopatías, mialgias, artralgias, cefalea, **exantema maculopapular troncal**, diarrea, baja de peso, sudoración nocturna.
- **Las manifestaciones que más deben hacer sospechar**:
 - **ÚLCERAS MUCOSAS** —orales, genitales o anales: muy sugerentes y poco frecuentes en otros cuadros mononucleósicos.
 - **Exantema maculopapular** en un adulto joven con fiebre y faringitis.
 - **Meningitis aséptica**, parálisis facial, síndrome de Guillain-Barré.
 - **Candidiasis oral** durante la fase aguda (por la caída transitoria de CD4).
- **La carga viral es MUY ALTA** (habitualmente > 100.000 copias/mL) y **la contagiosidad es máxima**: una fracción sustancial de las transmisiones ocurre en esta fase.

La regla diagnóstica Ante sospecha de infección aguda por VIH hay que solicitar **CARGA VIRAL (ARN)**, porque la **serología puede ser todavía negativa**. Pedir sólo la serología es el error que hace perder el diagnóstico.

Y todo síndrome mononucleósico con Monospot negativo obliga a descartar VIH agudo.

5. Diagnóstico: los marcadores y su cronología

Marcador	Detectable desde	Comentario
ARN viral (carga viral)	~10 días	El más precoz; se usa ante sospecha de infección aguda
Antígeno p24	~14-20 días	Incluido en los ensayos de cuarta generación
Anticuerpos IgM e IgG	~3-4 semanas, prácticamente todos a las 6-12 semanas	Base de los ensayos de tercera generación

El "**período de ventana**" es el intervalo entre la infección y la positividad del examen utilizado, y se ha acortado progresivamente con las generaciones de ensayos.

Generación del ensayo	Detecta	Ventana aproximada
1. ^a y 2. ^a	IgG	6-12 semanas
3. ^a	IgG e IgM	3-4 semanas
4. ^a (combinado o "dúo")	Antígeno p24 + anticuerpos	~2-3 semanas — es el recomendado como tamizaje
Pruebas rápidas	Anticuerpos (algunas también p24)	Variable; amplían el acceso al examen
Carga viral (ARN)	ARN	~10 días

6. El algoritmo diagnóstico

La combinación de las etapas: A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3.

La regla de la clasificación CDC 1993 Se considera SIDA a las categorías C (cualquiera) y a las categorías 3 (CD4 < 200), es decir A3, B3 y C1-C3.

La clasificación no retrocede: una vez alcanzada una etapa, el paciente la conserva aunque mejore con el tratamiento. Un paciente que tuvo neumonía por *Pneumocystis* con CD4 de 50 y hoy tiene CD4 de 700 sigue clasificándose como C3.

La revisión CDC de 2014 simplificó el sistema en etapas 0 a 3, con la etapa 0 para la infección documentada como reciente (menos de 180 días desde un examen negativo previo) y la etapa 3 para el SIDA, manteniendo la lógica de los CD4 y de las condiciones definitorias.

En Chile, la etapificación y los criterios de las garantías GES siguen la normativa del MINSAL: verificar la versión vigente.

9. Condiciones definitorias de SIDA

Sistema	Condiciones
Respiratorio	Neumonía por <i>Pneumocystis jirovecii</i> · Tuberculosis pulmonar · Neumonía bacteriana recurrente (>= 2 episodios en 12 meses) · Histoplasmosis y coccidioidomicosis diseminadas
Sistema nervioso central	Toxoplasmosis cerebral · Criptococosis extrapulmonar (meningitis) · Linfoma primario del SNC · Leucoencefalopatía multifocal progresiva · Encefalopatía por VIH
Gastrointestinal	Candidiasis esofágica · Colitis o esofagitis por CMV · Criptosporidiosis o isosporiasis crónica (> 1 mes) · Herpes simplex con úlceras mucocutáneas > 1 mes
Diseminado	Complejo <i>Mycobacterium avium</i> diseminado · Tuberculosis extrapulmonar · Bacteriemia recurrente por <i>Salmonella</i> · Retinitis por CMV
Neoplasias	Sarcoma de Kaposi · Linfoma no Hodgkin (Burkitt, inmunoblástico) · Cáncer cervicouterino invasor
Otros	Síndrome de desgaste (wasting)** por VIH

10. La primera consulta: evaluación clínica

Objetivos: confirmar el diagnóstico, evaluar la etapa, buscar infecciones oportunistas y comorbilidades, iniciar el tratamiento y vincular a la persona a la atención.

Anamnesis: - Fecha probable de la infección y último examen negativo previo (define la etapa 0). - Síntomas actuales por sistema: fiebre, baja de peso, sudoración nocturna, diarrea, disnea, tos, cefalea, alteración visual, odinofagia o disfagia, lesiones cutáneas, síntomas neurológicos. - Antecedentes de infecciones oportunistas y de ITS. - Tuberculosis: contactos, antecedente personal, síntomas. - Prácticas sexuales y de consumo de sustancias, sin juicio. - Parejas sexuales y estado serológico, para orientar el estudio de contactos. - Salud sexual y reproductiva: deseo de embarazo, anticoncepción. - Salud mental: depresión, ansiedad, consumo problemático — determinantes de la adherencia. - Red de apoyo, situación laboral y habitacional, seguro de salud, y a quién ha revelado el diagnóstico. - Fármacos y suplementos (interacciones con la TARV). - Vacunas previas.

Examen físico completo, con especial atención a: - Piel y mucosas: sarcoma de Kaposi, dermatitis seborreica, foliculitis, molusco, herpes, leucoplasia vellosa oral, candidiasis oral. - Cavidad oral y dentadura. - Fondo de ojo si CD4 < 100 (retinitis por CMV). - Adenopatías. - Examen neurológico y cognitivo. - Examen anogenital, y tamizaje de displasia cervical y anal según corresponda. - Peso, talla, índice de masa corporal, presión arterial.

11. La primera consulta: exámenes

Categoría	Exámenes
Estado de la infección	Carga viral de VIH · Recuento de CD4 (absoluto y porcentaje) · Genotipificación de resistencia basal (recomendada antes de iniciar la TARV, para detectar resistencia transmitida) · Serología de VIH confirmatoria si no está
Antes de ciertos fármacos	HLA-B5701* (obligatorio antes de abacavir: predice hipersensibilidad grave) · Tropicismo viral si se considera maraviroc

Categoría	Exámenes
Coinfecciones	Hepatitis B (HBsAg, anti-HBc, anti-HBs) · Hepatitis C (anti-VHC, con ARN si es positivo) · Hepatitis A (IgG) · Sífilis (VDRL/RPR y prueba treponémica) · Tamizaje de gonorrea y clamidia con muestras según la práctica sexual (faríngea, rectal y genital) · Tuberculosis: PPD o IGRA y radiografía de tórax · <i>Toxoplasma</i> IgG · CMV IgG · Chagas si hay antecedente epidemiológico · <i>Strongyloides</i> si hay exposición
Si CD4 < 100	Antígeno criptocócico sérico (tamizaje recomendado por la OMS) · Fondo de ojo
Generales y de comorbilidad	Hemograma, función renal con estimación de la filtración glomerular, orina completa y relación proteinuria/creatininuria (tenofovir), pruebas hepáticas, perfil lipídico y glicemia (riesgo cardiovascular), electrolitos, test de embarazo cuando corresponda
Tamizaje oncológico	Papanicolaou cervical (y su seguimiento según norma); citología anal en poblaciones de riesgo según disponibilidad
Salud ósea	Densitometría en pacientes con factores de riesgo

12. Vacunación

La vacunación debe planificarse desde la primera consulta, y la respuesta es mejor con CD4 más altos y carga viral suprimida — otro argumento para el inicio precoz de la TARV.

Vacunas recomendadas (inactivadas)	Vacunas VIVAS
Hepatitis B (con verificación de anti-HBs; considerar esquemas de dosis alta o adyuvados)	Tres vírica y varicela: contraindicadas si CD4 < 200/μL. Se pueden administrar con CD4 ≥ 200 sostenido si el paciente es susceptible
Hepatitis A (en susceptibles, HSH, hepatopatía, uso de drogas)	Fiebre amarilla: evaluación individualizada; contraindicada con CD4 < 200
Neumocócica (conjugada y polisacárida según esquema)	Zóster VIVA atenuada: contraindicada
Influenza anual	
COVID-19 según esquema vigente	
dTpa / dT	
Virus papiloma humano	
Meningocócica (conjugada tetravalente; y serogrupo B según riesgo)	
Zóster RECOMBINANTE adyuvada (no viva): indicada	

Verificar el calendario vigente del Programa Nacional de Inmunizaciones.

13. Cuándo iniciar la terapia antirretroviral

La respuesta actual es inequívoca: SE TRATA A TODA PERSONA CON VIH, INDEPENDIENTEMENTE DEL RECuento DE CD4, Y LO ANTES POSIBLE.

El fundamento:

- **START** (*N Engl J Med* 2015) y **TEMPRANO/ANRS 12136**: el inicio inmediato de la TARV frente al diferido **redujo la morbilidad grave y la mortalidad**, incluso con CD4 > 500.
- **HPTN 052** y los estudios **PARTNER** y **PARTNER2**: la supresión virológica **previene la transmisión sexual** — el fundamento de **I=I (indetectable = intransmisible)**.
- **La inflamación crónica** asociada a la replicación viral persistente aumenta el riesgo cardiovascular, renal, óseo, hepático, neurocognitivo y oncológico, incluso con CD4 normales.

Inicio rápido o el mismo día: cada vez más recomendado, porque **mejora la vinculación a la atención y acelera la supresión virológica**, sin comprometer la seguridad, siempre que se aseguren el seguimiento y la educación.

Las excepciones que exigen precaución —donde el inicio inmediato puede desencadenar un **síndrome inflamatorio de reconstitución inmune** grave:

Situación	Conducta
Meningitis criptocócica	DIFERIR la TARV 4-6 semanas tras iniciar el tratamiento antifúngico: el inicio precoz aumenta la mortalidad
Meningitis tuberculosa	Diferir habitualmente 4-8 semanas, según la evidencia y el criterio clínico
Tuberculosis (otras formas)	Iniciar la TARV dentro de las 2 semanas si CD4 < 50 , y dentro de las 8 semanas en el resto
Retinitis por CMV	Coordinar con oftalmología por el riesgo de uveítis por reconstitución inmune
Otras oportunistas	En general se inicia precozmente (dentro de las 2 semanas), con vigilancia del SIRI

14. Vinculación a la atención y retención

La **cascada de atención** describe los pasos entre el diagnóstico y la supresión virológica, y **cada paso pierde pacientes**: diagnosticados -> vinculados -> retenidos en control -> en tratamiento -> **con carga viral suprimida**.

Las metas globales (ONUSIDA) son 95-95-95: que el 95 % de las personas con VIH conozca su diagnóstico, que el 95 % de ellas esté en tratamiento, y que el 95 % de las tratadas tenga **carga viral suprimida**.

Lo que mejora la retención:

- **Vinculación inmediata** tras el diagnóstico, idealmente el mismo día.
- **Consejería y acompañamiento** por equipo multidisciplinario (matrona, enfermería, psicología, trabajo social).
- **Abordaje de las barreras**: salud mental, consumo de sustancias, situación habitacional y laboral, transporte, estigma.
- **Esquemas simples**, de un comprimido diario, bien tolerados.
- **Educación sobre I=I**, que además reduce el estigma y mejora la calidad de vida.
- **Apoyo entre pares** y organizaciones comunitarias.

15. Errores frecuentes

- **Pedir sólo la serología** ante sospecha de infección aguda, en lugar de la **carga viral**. - **No pensar en VIH agudo** ante un síndrome mononucleósico con Monospot negativo, exantema o úlceras mucosas. - **Comunicar un diagnóstico con un solo resultado reactivo**, sin confirmación. - **Pedir el examen sin consentimiento ni consejería**, contraviniendo la Ley 19.779. - **Revelar el diagnóstico** a familiares o parejas sin autorización de la persona. - **Usar lenguaje estigmatizante** ("paciente VIH", "sidoso", "contagiar", "grupos de riesgo"). - **Confundir VIH con SIDA**, o "bajar" la etapa cuando el paciente mejora: **la clasificación no retrocede**. - **Diferir el inicio de la TARV** esperando un recuento de CD4 más bajo. - **Iniciar la TARV inmediatamente en una meningitis criptocócica** — hay que diferirla 4-6 semanas. - **No solicitar HLA-B5701 antes del abacavir***. - **No tamizar coinfecciones** (hepatitis B y C, sífilis, tuberculosis, ITS con muestras según la práctica sexual). - **No solicitar antígeno criptocócico ni fondo de ojo** con CD4 < 100. - **No vacunar**, o administrar vacunas vivas con CD4 < 200. - **No abordar la salud mental y las barreras sociales**, que son los principales determinantes de la adherencia.

16. Perlas de alto rendimiento

- **Ante sospecha de infección aguda: CARGA VIRAL**, porque la serología puede ser negativa.
- **Úlceras mucosas + exantema + fiebre en un adulto joven = VIH agudo hasta demostrar lo contrario**.
- **La contagiosidad es máxima en la infección aguda**.
- **Tamizaje con ensayo de 4.ª generación; confirmación con diferenciación VIH-1/VIH-2; carga viral si se sospecha infección aguda**.
- **En Chile el examen es voluntario, con consentimiento y consejería (Ley 19.779)**, y el VIH está en las garantías GES.
- **La clasificación CDC no retrocede**: una vez C3, siempre C3.
- **SIDA = categoría C, o CD4 < 200 (A3, B3)**.
- **Se trata a TODA persona con VIH, sin importar los CD4, y lo antes posible (START)**.
- **La excepción es la meningitis criptocócica: diferir la TARV 4-6 semanas**.
- **HLA-B5701 antes del abacavir***, siempre.
- **Con CD4 < 100: antígeno criptocócico sérico y fondo de ojo**.
- **Vacunas vivas contraindicadas con CD4 < 200**; la vacuna recombinante contra zóster sí se puede.

- **I=I: indetectable es intransmisible.** Es un mensaje clínico, preventivo y de reducción del estigma.
- **El lenguaje es parte del tratamiento:** "persona que vive con VIH", "transmitir", "prácticas de riesgo".

17. Bibliografía esencial

- Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. *Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents with HIV*. Department of Health and Human Services. Edición vigente.
- European AIDS Clinical Society (EACS). *Guidelines*. Edición vigente.
- INSIGHT START Study Group. Initiation of antiretroviral therapy in early asymptomatic HIV infection. *N Engl J Med*. 2015;373:795-807.
- Cohen MS, Chen YQ, McCauley M, et al. Prevention of HIV-1 infection with early antiretroviral therapy (HPTN 052). *N Engl J Med*. 2011;365:493-505.
- Rodger AJ, Cambiano V, Bruun T, et al. Risk of HIV transmission through condomless sex in serodifferent gay couples with the HIV-positive partner taking suppressive antiretroviral therapy (PARTNER2). *Lancet*. 2019;393:2428-38.
- Centers for Disease Control and Prevention. Revised surveillance case definition for HIV infection — United States, 2014. *MMWR Recomm Rep*. 2014;63(RR-03):1-10.
- Centers for Disease Control and Prevention y Association of Public Health Laboratories. *Laboratory Testing for the Diagnosis of HIV Infection: Updated Recommendations*. 2014 y actualizaciones.
- World Health Organization. *Consolidated guidelines on HIV prevention, testing, treatment, service delivery and monitoring*. Edición vigente.
- Ministerio de Salud de Chile. Guía Clínica GES VIH/SIDA; Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS; Ley 19.779. Verificar versiones vigentes.